SDD 64 Sujet n°2

Spécialité : ORL

Date : 07/10/2023
Auteur : SHARPIN-GUION Marion, ELAYLI Robin (DES Psychiatrie Grenoble, ECN 2023)
Relecteur(s) : Lucie-Lou Vial (DES MAR, EN 2023/2024)

Domaine d'apprentissage principal	Examen clinique
Domaine d'apprentissage secondaire	Entretien, interrogatoire
Item(s) en lien avec la station	ITEM 103 - Vertiges
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 64 Vertiges, sensation vertigineuse
Matériel nécessaire à la station	- Une feuille, un crayon - Un Stylo - Une lampe/un téléphone avec flash
Contexte de la station	

ECOS TACFA

INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes médecin aux urgences et recevez Mme Bliss, 56 ans, envoyée par son médecin traitant pour un 1er épisode de vertiges très handicapant.

Son médecin précise dans le courrier que l'examen otologique à l'otoscope et cardio-vasculaire est normal. Son seul antécédent : Hypertension artérielle, traitée par irbésartan et hydroxy-chlortiaizide.

Les infirmières l'ont vue, et vous communiquent que les constantes sont correctes et le test d'hypotension orthostatique est normal.

Après l'interrogatoire, vous suspectez un vertige paroxystique positionnel bénin.

Consignes :
Vous avez 8 minutes pour :

- Enoncer les éléments à rechercher à l'examen clinique orienté pour confirmer le diagnostic et éliminer les diagnostics différentiels

Vous ne devez pas :

- Donner de diagnostic
- Prescrire de traitement
- Faire un examen otoscopique

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station sans patient standardisé.

ECOS TACFA

GRILLE D'ÉVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)		
Examen clinique		
1.	Recherche un nystagmus spontanée	1 pt
2.	Recherche un nystagmus à la fixation oculaire	1 pt
3.	Recherche un nystagmus provoqués par appui sur tragus/pavillon d'oreille de chaque côté	1 pt
4.	Exécute une manoeuvre de **Dix et Hallpike** : - Mettre le/la patient.e assis.e - Positionner la tête à 45° du côté atteint - Couché patient du côté opposé à l'atteinte, la tête maintenue à 45°	1 pt
5.	Exécute le **Test d'Halmagyi** ou Head Impulse Test : Demande au patient de fixer le nez de l'examinateur. Imprime un mouvement rapide dans un sens (> 60° dans le plan horizontale), de la tête et regarde si les yeux continuent de fixer le point donné malgré les mouvements de tête	1 pt
6.	Recherche une **dysmétrie** via au moins une des deux manoeuvre suivante : - Doigt-nez : Patient debout ou assis, demande avec le bout du doigt de venir toucher le bout du nez, et alterne chaque main. - Talon-genou : Patient couché, demande de poser le talon sur le genou controlatéral, puis de faire glisser le talon le long du tibia.	1 pt
7.	Examen de **l'oculomotricité** : ok si 1 sur 2 ● L'étudiant.e met 2 crayons/doigts de chaque côté, dans les champs périphériques visuels du patient, et demande de fixer de façon alternée chaque crayon ● Poursuite oculaire d'un crayon/doigt balayé horizontalement puis verticalement	1 pt
8.	Fait un **test de Romberg** : Demande au patient debout de joindre les pieds et de fermer les yeux	1 pt

9.	Teste **l'ouïe** du patient : fait un bruit similaire de chaque côté, près des oreilles, et demande si le/la patient.e entend mieux ou moins bien d'un côté.	1 pt
10.	Recherche **déficit sensitif** aux 4 membres (au moins 1 des suivant) : • Test de la sensibilité analgésique • Test de sensibilité épicritique ou protopathique (Demande au patient si sent quand le touche)	1 pt
11.	**Testing musculaire** : Demande au patient de bouger par lui même ses membres	1 pt

Communications et attitudes (ICI) (max 5 grilles)		
1.	**1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair**	1 pt

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

2.	**2. APTITUDE À QUESTIONNER**	1 pt

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

3.	**4. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE**	1 pt

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

4.	**9. APTITUDE À STRUCTURER L'EXAMEN CLINIQUE**	1 pt

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
L'examen clinique est incomplet et désorganisé ou ne fait pas l'examen clinique	Les éléments recherchés sont peu ciblés, s'attarde à des manœuvres inutiles	L'examen clinique est raisonnablement organisé et couvre les éléments essentiels	L'examen clinique suit un enchaînement logique et est centré sur le problème, il n'y a pas de manœuvre inutile	L'examen est réalisé sans erreur avec un but précis, démarche intégrée

5.	**5. COMMUNICATION NON VERBALE**	1 pt

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Se comporte de manière inappropriée (p. ex. ne regarde pas son interlocuteur, se comporte de manière offensante ou agressante) ou porte des jugements	Tente d'établir un contact visuel. Présente les difficultés à établir la conversation (p.ex. priorise l'accomplissement de la tâche clinique) et cela peut induire la frustration du patient/pair	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Établit la conversation	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Est attentif aux indices du patient/pair et réagit de manière appropriée par son comportement/gestes.	Montre une bonne maîtrise de ses comportements et cherche à les adapter afin de favoriser la conversation /établir une relation.

TOTAL (max 20 items)	**…/20 points**

<u>Éléments de rétroaction :</u> (facultatif)

PARTIE INTERROGATOIRE :

Type de vertige possible	- Rotatoire « comme dans un manège/pièce qui tourne ». Dans ce cas, il faut préciser le sens où cela tourne (horaire ou anti-horaire - Instabilité « comme dans un bateau » - De déplacement (plus rare) : Tombe ou impression de montée - Oscillopsie : Vision centrale instable lors de mouvement - Sensation d'ébriété

	- Sensation de malaise - Trouble de l'équilibre
Circonstance d'apparition	- Spontanée/au repos - Déclencher ou aggraver par un élément : ● Dans une certaine position (évoque vertige positionnel paroxystique bénin) ● Rotation rapide de la tête (paroxysmie vestibulaire, déficit canalaire) ● Bruit (effet Tullio, fistule labyrinthique) ● Mouchage ou tout effort à glotte fermée (équivalent de manœuvre de Valsalva, fistule labyrinthique) ● Passage assis-debout ou couché-debout (en faveur d'hypotension orthostatique) ● Sorties dans la rue (agoraphobie), grands magasins (agoraphobie ou dépendance visuelle) ● Conduire une voiture sur autoroute (dépendance visuelle + composante émotionnelle, « syndrome de l'autoroute » ● Monter sur une échelle (phobie des hauteurs, faux vertige) ● Course à pied (syndrome du jogger) ● Freinages ou virages dans la voiture (syndrome otolithique)
Durée du vertige	- Quelques secondes à 2 min - 15min à 5h - Plus de 5h
Grande syndrome vertigineux	- Grande crise vertigineuse unique (évocatrice de névrite vestibulaire) - Plusieurs épisodes vertigineux : ● Date de la 1ère crise ? de la dernière crise ? ● Fréquence approximative (nombre par semaine, par mois ou par année) ? - Vertige permanent (souvent à type d'instabilité ou de tangage).
ATCD	- Otologiques : chirurgie, VPPB déjà traité - Vasculaires : HTA, cardiopathie, artériopathie - Traumatique : traumatisme crânien avec perte de connaissance, barotraumatisme, trauma cervical - Neurologiques : accidents vasculaires, sclérose en plaques - Médicamenteux (hypotenseurs, neuroleptiques, ototoxiques…) - Infectieux : méningite, otite, maladie de Lyme, VIH.
Symptôme associés	Si symptôme, rechercher si sont là pendant et/ou en dehors des crises vertigineuses : - Signes d'atteinte cochléaires : **acouphènes**, **surdité**. - Troubles neurovégétatifs : **nausées**/**vomissements**, pâleur, sueurs, diarrhée - Céphalées (localisation, durée) rechercher critères de migraine et d'HTIC - Cervicalgies (non rares si déficit labyrinthique). <u>Attention si unilatérale spontanée ou surcroît en contexte de trauma = évoque dissection</u> - Équivalent de migraine : Sonophobie, photophobie, fourmillement concomitants - Troubles moteurs ou sensitifs, maladresse de main (boutonner sa chemise), diplopie ou baisse acuité visuelle (évoquent atteinte cérébelleuse, sclérose en plaques ou une

	atteinte vasculaire du tronc)
Impact	Impact sur la vie quotidienne, important pour la stratégie thérapeutique, via échelle de handicap AAO-HNS : ● 0 : Aucun handicap. ● 1 : Vertiges (intermittents ou continus) empêchant de travailler dans certaines situations à risque. ● 2 : Vertiges nécessitant un travail sédentaire. ● 3 : Vertiges empêchant toute activité)

PARTIE EXAMEN CLINIQUE

I) Examen des yeux

Rechercher nystagmus, qui peut être due à une atteinte du système d'équilibration périphérique (vestibule et nerf, noyau*) ou central (noyau* et structure supérieure)
* Une atteinte des noyaux du VIII peut donné les deux types de nystagmus cependant

Périphérique	Central
Atténué par la fixation oculaire	Non atténué par la fixation oculaire
Ne changeant pas de direction	Peut changer de direction, en fonction de la direction du regard
Souvent observé uniquement dans la direction de la phase rapide	
- Horizonto-rotatoire - Vertico-rotatoire	- Peut être vertical ou rotatoire
- Sur les 2 yeux	- Que sur un oeil
- Compensant rapidement	- Persistant dans le temps
- Proportionnel aux vertiges	- Non proportionnel à vertige

Nystagmus spontanée	- Sans stimulation, on identifie 3 degrés: ● 1er degré : Dans regard latéral du même côté que sens nystagmus (ce qui peut être physiologique) ● 2nd degré : Dans regard centré ● 3ème degré : Dans regard opposé au côté du sens du nystagmus		
			Le plus fréquent sera une cupulolithiase du semi-circulaire postérieur du même côté que le nystagmus (> 90 % cas). Le nystagmus sera : - Vertico-rotatoire, vertical supérieur et rotatoire battant vers le sol (géotropique) après quelque secondes de latence

<table>
<tr><td rowspan="4">Nystagmus provoqué</td><td rowspan="2">Dix et Hallpike</td><td>Suspicion cause périphérique</td><td>- Type crescendo-décrescendo (augmente, puis diminue, puis augmente, puis diminue…)
- Disparaît progressivement en < 20 secondes.
- Accompagné d'un violent vertige.
- S'inverse au retour à la position assise.
- Décubitus latéral du même côté le fait réapparaître, mais moins importante (habituation).
- Décubitus latéral controlatéral ne donne ni nystagmus ni vertige.</td></tr>
<tr><td>Suspicion cause centrale</td><td>- Nystagmus vertical inférieur ou oblique
- Pas d’épuisement du phénomène
- Nystagmus positionnel <u>sans vertige</u>
- Vomissements <u>avec peu de vertige</u></td></tr>
<tr><td>Test d’Halmagyi (ou head impulse test)</td><td colspan="2">Évalue réflexe vestibulo-oculaire (les yeux suivent de manière proportionnel les mouvements de la tête) dans plan horizontale
- Normal (n’élimine pas atteinte vestibulaire) = yeux fixés sur la cible.
- Déficit du vestibule = Yeux emporté dans le sens du déplacement de la tête, et font une saccade pour revenir à la position voulu. Sens du mouvement de tête où se produit cela indique le coté atteint.
NB : Le poly d’ORL dit que le Test d’Halmagyi possède aussi après un mouvement de 60° dans un sens, <u>un mouvement de faible amplitude (20°) dans le même sens</u> (non retrouvé dans le poly de neurologie)</td></tr>
<tr><td>Fistule labyrinthique</td><td colspan="2">La pression du tragus/du pavillon de l’oreille change la pression du canal auditif externe, et déclenche un nystagmus.</td></tr>
<tr><td>Examen oculaire</td><td colspan="3">Ces examens recherches plutôt des atteintes centrales
- Etude oculomotricité (intégrité des nerfs faciaux III, IV et VI)
- Examen des pupilles aux réflexes photo-moteurs (intégrité des nerfs faciaux II)
- Dans fixation du regard excentré (Fixe un doigt/crayon à 30 cm et 30° à droite et à gauche) : Si saccade/nystagmus dans les fixation périphérique, évoque hypermétrie /dysmétrie cérébelleuse (le cervelet n’inhibe plus assez les noyaux oculomoteurs).
- Recherche skew deviation : Fixe dnez de l’examinateur puis cache un oeil, puis le découvre. Si l’oeil se ramène vers la cible quand découvre l’oeil, évoque lésion centrale (supranucléaire du tronc cérébrale, souvent de Syndrome de Wallenberg = AVC de la région latéral rétro-olivaire du bulbe)</td></tr>
</table>

II) Etude vestibulaire

- **Etude de la marche** Sur une ligne/funambule yeux ouvert
- **Test de Romberg** (yeux fermé debout, bras tendus en avant) =
  - Si déviation d’un côté, évoque une atteinte vestibulaire (on supprime l’information visuelle, et les vestibules ne peuvent pas compenser pour maintenir l’équilibre).

- Si syndrome cérébelleux, on observe une danse des talon (déviation sans sens majeur, avec réaxation par contraction des muscle des mollets pour rééquilibrer)

- **Test de Fukuda** = Piétinement sur place, yeux ouvert, puis fermé, pour voir si le patient dévie dans un sens (normal si déviation < 60°). Une déviation > 60° évoque une atteinte du vestibule du côté opposé.
- **Marche en étoile** = Ferme les yeux, puis 3 pas avant et 3 pas arrière. Si atteinte vestibulaire, marche en arrière

III) Autres examens

- Examen moteur par testing moteur des 4 membres
- **Examen des autres paires crâniennes** :
  - II : Réflexe photomoteur
  - V : Examen sensitif du visage
  - VII : Evaluation du nerf facial en demandant de sourire, gonfler les joues…
  - VIII : Recherche déficit auditif accompagnant
  - XI : Mouvement de torsion du cou, de haussement d'épaule
  - XII : Tire la langue (regarder si déviation d'un côté)
- **Examen cardio-vasculaire** : Recherche HTA, hypotension orthostatique, souffle cardiaque, trouble du rythme
- **Examen sphère ORL** à l'otoscope (recherche signe traumatisme, infection, ou de fistule)

ECOS TACFA
SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Vous êtes médecin aux urgences. Vous recevez la patiente Mme Bliss, âgée de 56 ans qui se plaint de vertiges. Le médecin traitant a fourni un courrier pour explorer ce vertige, en disant dedans que l'examen otoscopique à l'otoscope est normal

Plan de la station ECOS :

Le patient est allongé.

Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :

J’ai la tête qui tourne terriblement depuis ce matin, c'est horrible.

Identité du patient :

Madame Catherine Bliss, 56 ans.
1m57, 68kg

Mode de vie :

Cadre dans une grande entreprise
Mariée, 2 fils de 17 et 23 ans, qui vivent encore chez elle
Tabac : 1 paquet/jour depuis l’âge de ses 20 ans
Alcool occasionnel

Comportement global :

Allongée, ne bouge pas beaucoup, a des vertiges au moindre mouvement, mais quand elle ne bouge pas ça va
A la nausée, a vomi 2 fois ce matin donc ne se sent pas très bien

Antécédents personnels :

Hypertension artérielle

Antécédents familiaux :

Aucun

Médicaments :

- Irbesartan
- Hydrochlorothiazide (pas obligé de savoir dire le nom précisément, possible de

dire « irbesartan et hydro..quelque chose »)
- « J'ai essayé de prendre du doliprane pour calmer les vertiges mais ça n'a pas marché »

Symptômes :

Depuis ce matin au réveil, présence de vertiges très intenses.
Dire à la demande de l'étudiant

- Vertiges très intenses, d'une durée de quelques minutes, quand vous bougez la tête
- Non permanent, mais revient souvent
- A la nausée ++, a vomi 2 fois ce matin avant de venir

Si l'étudiant demande si ça tourne ou si ça tangue « j'ai l'impression d'être dans un manège »
Ca tourne vers la droite

Pas d'acouphènes (ni sifflement, ni bourdonnement dans les oreilles), pas de sensation de perte d'audition, pas de troubles visuels
Pas mal à la tête.
Pas de douleur nulle part
1ère fois que ça vous arrive et ça vous fait très peur

Pendant l'examen clinique, si l'étudiant vous fait vous lever ou vous tourne la tête, dites que vous avez le vertige.
Faites toutes les actions que l'étudiant vous demandera de faire et vous devez réussir à les effectuer.

Constantes :

La tension et les constantes ont été prises par l'infirmier à l'accueilet son normales
- TA : 138/87
- FC 75 bpm
- SpO2 98%
- Glycémie 1,12 g/l

Données de l'examen clinique pour l'examinateur

Présence d'un nystagmus horizonto-rotatoire
Romberg négatif
Pas de dysmétrie
Pas de déficit sensitivomoteur

Examen des paires crâniennes sans anomalie